

医疗机构检查检验结果互认规范

Specification for mutual recognition of inspection and testing results of medical
institution

2025 - 03 - 04 发布

2025 - 06 - 03 实施

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 互认规则 1

 4.1 互认内容 1

 4.2 互认区域范围 2

 4.3 互认项目范围 2

 4.4 互认标识 2

 4.5 互认报告单 2

 4.6 不予互认条件 2

5 互认方式 2

 5.1 线下互认 3

 5.2 线上互认 3

6 互认平台功能与安全 3

 6.1 中心端功能 3

 6.2 客户端功能 4

7 评价与改进 4

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁夏回族自治区卫生健康委员会提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：宁夏回族自治区卫生健康委员会信息中心、宁夏医科大学总医院、宁夏回族自治区人民医院、高质标准化（宁夏）管理科学研究院。

本文件主要起草人：李宁、李春生、孙静、关振东、杨飞、吴涛、陈兵、万隆、郭少豫、冯伯凯、马婷婷、冯莹、石鹏飞、马立鹏、刘艳蓉。

医疗机构检查检验结果互认规范

1 范围

本文件规定了医疗机构检查检验结果互认规则、互认方式、互认平台功能与安全、评价与改进的要求。

本文件适用于医疗机构检查检验结果互认。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 28452 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求

GB/T 39725 信息安全技术 健康医疗数据安全指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

检查检验结果互认平台 mutual recognition platform for inspection and testing result

利用信息技术手段，实现跨区域、跨医疗机构的检查检验数据采集、编码维护、互认规则维护、数据查询、数据调阅、互认共享等功能的信息平台，包括中心端、客户端。（以下简称“互认平台”）

3.2

互认项目 mutual recognition project

经卫生健康行政部门组建、委托或指定质控中心开展质量评价后，满足国家级或地方质量评价指标的检查检验项目。

3.3

质控中心 quality control center

县级以上卫生健康行政部门为提高医疗质量和医疗服务水平，促进医疗质量安全同质化，实现医疗质量持续改进，根据管理工作需要组建、委托或指定的医疗质量控制组织。

4 互认规则

4.1 互认内容

4.1.1 检查结果，通过超声、X线、核磁共振成像、电生理、核医学等手段对人体进行检查，所得到的图像或数据信息。

4.1.2 检验结果，对来自人体的材料进行生物学、微生物学、免疫学、化学、血液免疫学、血液学、

生物物理学、细胞学等检验，所得到的数据信息。

4.2 互认区域范围

4.2.1 满足自治区级质量评价指标，并参加自治区级质控中心质量评价合格的检查检验项目，互认范围为全区。

4.2.2 满足市、县（区）级质量评价指标，并参加市、县（区）级质量评价合格的检查检验项目，互认范围为市、县（区）。

4.2.3 同级医疗机构之间，满足同级质量评价指标，并参加同级质控中心质量评价合格的检查检验项目，应互相认可。

4.2.4 低级别医疗机构对高级别医疗机构出具的属于互认范围的检查检验结果应予以认可。

4.3 互认项目范围

各级医疗机构所开展的检查检验结果互认项目应限于卫生健康行政部门正式公布的互认项目清单范围之内。

4.4 互认标识

4.4.1 医疗机构检查检验结果互认标志统一为 HR。检查检验项目通过相应质控中心质量评价的，医疗机构应标注“宁夏 HR”互认标识。

4.4.2 未按要求参加质量评价或质量评价不合格的检查检验项目，不应标注互认标识。

4.5 互认报告单

4.5.1 参加互认的医疗机构，在结果报告单和图像、胶片的右上方标注“宁夏 HR”互认标识。在具体互认项目名称左侧标注“★”，并进行互认备注说明。

4.5.2 检查检验结果应使用 SI 或其他公认单位系统的单位表示。

注：SI 为国际单位制，Système International d'Unités（法语）。

4.6 不予互认条件

出现以下情况，医疗机构及其医务人员可不予互认：

- 因病情变化，检查检验结果与患者临床表现、疾病诊断不符，难以满足临床诊疗需求的；
- 检查检验结果在疾病发展演变过程中变化较快的；
- 检查检验项目对于疾病诊疗意义重大的（如手术、输血等重大医疗措施前）；
- 患者处于急诊、急救等紧急状态下的；
- 对已有检查检验结果存疑的；
- 图像质量和方法不能满足诊断要求的；
- 患者或其家属要求进一步复查的；
- 涉及司法、伤残及病退等鉴定的；
- 系统数据异常或错误的；
- 其他情形确需复查的。

5 互认方式

5.1 线下互认

5.1.1 患者就诊时主动出具在其他医疗机构完成并标有互认标识的检查检验结果。

5.1.2 医务人员对患者提供的检查检验结果进行判断：

- 若检查检验结果符合互认规则，医务人员利用此结果进行诊断，并在医疗记录中注明结果来源和互认情况；
- 若检查检验结果不符合互认规则，医务人员可根据诊疗需求开具检查检验项目，并向患者予以说明。

5.2 线上互认

5.2.1 数据检索

患者就诊时，医务人员通过互认客户端检索该患者在其他医疗机构完成的且符合互认规则的检查检验结果信息。

5.2.2 患者授权

患者对医务人员调阅待互认的检查检验结果信息进行授权。

5.2.3 结果调阅

医务人员调阅待互认的检查检验项目信息，包括但不限于患者的基本信息、检查（检验）结果项目记录、影像报告等。

5.2.4 结果互认

医务人员结合患者病情和诊疗需求，对调阅到待互认的检查检验结果进行判断：

- 予以互认的，通过互认客户端引入互认结果信息，并填充在医疗记录中作为本次诊疗参考依据；
- 不予以互认的，通过互认客户端进行互认拒绝操作，如实填写拒绝理由，同时向患者说明原因。

6 互认平台功能与安全

6.1 中心端功能

6.1.1 数据采集与备份

6.1.1.1 应形成统一的采集标准和上传要求，在各医疗机构检查检验结果出具后 24h 内完成数据采集。

6.1.1.2 建立数据备份机制，做好全量、增量和异地备份。

6.1.2 编码维护

应形成统一的互认项目编码规则，对互认项目编码进行动态维护，能实现不同医疗机构产生的检查检验结果使用相同的编码进行比对、共享和互认。

注：互认项目编码维护是为确保不同医疗机构之间的检查检验结果能够相互认可，而建立并维护一套统一的编码体系。

6.1.3 规则维护

按照第4章的要求形成统一的互认规则，并进行动态维护和更新。

6.1.4 统计分析

能按照区域、机构、项目等维度进行包括但不限于检查检验结果互认数据的查询、统计和分析。

6.2 客户端功能

6.2.1 依据互认平台中心端的互认项目和规则，能自动检索、匹配、提醒医务人员待互认的患者检查检验项目结果信息，并支持患者授权。

6.2.2 支持医务人员调阅患者待互认的检查检验结果信息，完成互认或拒绝的操作；支持将已互认的检查检验结果信息，通过接口方式自动回写至医院电子病历文档。

6.2.3 支持医务人员查看个人操作记录及互认工作统计情况。

注：客户端是进行互认项目查询、结果调阅、互认共享服务的用户端，使医生能够快捷、方便地完成检索、授权、调阅、互认等操作。

6.3 互认信息安全

6.3.1 互认平台网络安全应符合 GB/T 22239 中规定的第三级安全保护要求。

6.3.2 互认平台系统安全应符合 GB/T 28452 的要求。

6.3.3 互认平台数据安全应按照 GB/T 39725 执行。

6.3.4 互认平台数据接口应采用包括但不限于身份鉴别、访问控制、安全传输、操作抗抵赖、过程追溯等手段维护安全。

6.3.5 采用多因素认证方法，加强身份认证和访问控制；保护患者隐私，落实授权访问机制，对患者敏感隐私数据脱敏保护。

7 评价与改进

7.1 医疗机构应对互认工作执行情况、检查检验结果数据质量等方面进行评价考核，发现问题及时整改。

7.2 各级卫生健康行政部门、质控中心应对医疗机构检查检验互认工作进行监督检查，对存在问题的医疗机构提出改进要求。

7.3 互认项目清单应定期向社会公开，接受社会监督。